

ДГМУ 2025

Офтальмология

Итоговый ЛФ V2 2025 by студенты

#1

Самой тонкой стенкой орбиты является:

Наружная стенка

Верхняя стенка

Внутренняя стенка

Нижняя стенка

Задняя стенка

#2

Слезный мешок расположен:

Интраорбитально;

Экстраорбитально;

Частично интра-, частично экстраорбитально

В области среднего носового хода

В области нижнего носового хода

#3

Слезно-носовой канал открывается в:

Нижний носовой ход

Средний носовой ход

Верхний носовой ход

В конъюнктивальный мешок

В гайморову пазуху

#4

Отток внутриглазной жидкости из передней камеры осуществляется через:

Область зрачка

Капсулу хрусталика

Корнеосклеральную трабекулу

Склеру

Радужку

#5

Зрительный нерв выходит из орбиты через:

Верхнюю глазничную щель

Зрительное отверстие

Нижнюю глазничную щель

Круглое отверстие

Крылонебную ямку

#6

Хориоидея выполняет:

Трофическую функцию для сетчатки

Функцию преломления света

Функцию восприятия света

Формообразующую для глазного яблока

Аккомодационную функцию

#7

Сетчатка выполняет функцию:

Преломления света

Трофическую

Восприятия света

Секреторную

Регуляции внутриглазного давления

#8

Внутриглазную жидкость вырабатывает:

Радужка

Хориоидея

Хрусталик

Цилиарное тело

Роговица

#9

Тенонова капсула отделяет:

Сосудистую оболочку от склеры

Сетчатку от стекловидного тела

Глазное яблоко от клетчатки орбиты

Сетчатку от хориоидеи

Хрусталик от стекловидного тела

#10

Боуменова мембрана находится:

Между эпителием роговицы и стромой

Между стромой и десцеметовой мембраной

Между десцеметовой мембраной и эндотелием

Между эндотелием и камерной влагой

Перед эпителием роговицы

#11

Хориоидея питает:

Наружные слои сетчатки

Внутренние слои сетчатки

Хрусталик

Зрительный нерв

Роговицу

#12

Самая большая часть зрительного нерва :

Интрабульбарльная

Интракраниальная

Интраканаликулярная

Интраорбитальная

Область хиазмы

#13

Внутриглазная жидкость предназначена для:

Питания сетчатки

Питания радужки и цилиарного тела

Смывания инородных частиц с поверхности глазного яблока

Питания роговицы и хрусталика

Питания зрительного нерва

#14

«Мышечная воронка» берет свое начало от:

Круглого отверстия

Сухожильного кольца вокруг канала зрительного нерва

Верхней глазничной щели

Нижней глазничной щели

Решетчатой пазухи

#15

Кровоснабжение глазного яблока осуществляется:

Глазной артерией

Слезной артерией

Решетчатыми артериями

Лицевой артерией

Надблоковой артерией

#16

Задние короткие цилиарные артерии питают: если 1 ответ то наружные слои

Роговицу

Радужку

Склеру

Наружные слои сетчатки

Зрительный нерв

#17

Вещество хрусталика это:

Соединительная ткань

Нервная ткань

Эпителиальная ткань

Жировая клетчатка

Внутриглазная жидкость

#18

Чему равен угол зрения при остроте зрения в 1.0?

1 угловой минуте

1 градусу

5 угловым минутам

2 градусам

5 градусам

#19

Какой из участков сетчатки обеспечивает наиболее высокую остроту зрения?

Центральная ямка желтого пятна

Желтое пятно на всем протяжении

Область диска зрительного нерва

Острота зрения на всех участках сетчатки одинаковая

Периферия сетчатки

#20

Что такое оптотип?

Буква, цифра или другой знак, используемый для определения остроты зрения

Объект для исследования слепого пятна

Объект для исследования темновой адаптации

Буква, цифра или другой знак для исследования цветового зрения

Объект для исследования поля зрения

#21

При исследовании остроты зрения по таблицам в течение скольких секунд следует демонстрировать оптотип?

1-2

2-3

5

10

20

#22

Как называется состояние, когда отсутствует восприятие зеленого цвета?

Дейтеранопия

Протонопия

Тританопия

Дейтераномалия

Протаномалия

#23

Для какой цели служит аномалоскоп?

Для определения темновой адаптации

Для исследования цветоощущения

Для обнаружения патологии поля зрения

Для определения остроты зрения

Для исследования рефракции

#24

Исследуемый одним глазом правильно называет все знаки в полихроматических таблицах Рабкина, а другим глазом их путает. Какое у него расстройство цветоощущения более вероятно?

Врожденное

Приобретенное

Может быть и то и другое

По приведенным данным установить нельзя

Осложненное

#25

У больного после экстракции катаракты все предметы оперированным глазом кажутся окрашенными в голубой цвет. Какое это состояние цветоощущения?

Эритропсия

Ксантопсия

Хлоропсия

Цианопсия

Монохромазия

#26

После отравления больной все стал видеть в желтом цвете. Как назвать такое цветоощущение?

Ксантопсия

Эритропсия

Хлоропсия

Цианопсия

Монохромазия

#27

Что такое скотома?

Опухоль глазного яблока темного цвета

Очаговый дефект поля зрения не доходящий до границ

Концентрическое сужение поля зрения

Ограниченные дефекты поля зрения, доходящие до его границ

Отсутствие половины поля зрения

#28

У больного правосторонняя гомонимная гемианопсия Где локализуется очаг поражения?

В зрительных нервах до хиазмы

В центре хиазмы

В зрительном тракте, правом

В зрительном тракте, левом

В наружных отделах хиазмы

#29

К какому времени достигается максимальная темновая адаптация?

Через 10 минут

Через полчаса

Через час

Через 2 часа

Через 3 минуты

#30

Как называется прибор, предназначенный для исследования светоощущения?

Периметр

Адаптометр

Кампиметр

Аномалоскоп

Гониоскоп

#31

Функцией каких элементов сетчатки обеспечивается сумеречное и ночное зрение ?

Колбочками

Ганглионарными клетками

Палочками

Клетками пигментного эпителия

Биполярами

#32

Способны ли палочковые фоторецепторы различать цвета? Если да, то в какой степени в сравнении с колбочками?

Да

Нет

- В более высокой
- В меньшей степени
- В равной степени

#33

Какие элементы сетчатки имеют самую высокую светочувствительность?

Палочки

- Колбочки
- Биполярные клетки
- Ганглионарные клетки
- Клетки пигментного эпителия

#34

Что характеризует физическую рефракцию глаза?

Преломляющая сила оптической системы глаза

- Положение главного фокуса по отношению к сетчатке
- Преломляющая сила хрусталика при выключенной аккомодации
- Преломляющая сила роговицы
- Отношение фокусного расстояния к длине передне-задней оси глаза

#35

В каких единицах измеряется клиническая рефракция ?

- Диоптриях
- Метрах
- Относительных числах**
- Процентах
- Угловых минутах

#36

Задний главный фокус расположен перед сетчаткой. Какой это вид рефракции?

Эмметропия.

Миопия,

Гиперметропия

Физическая рефракция

Астигматизм

#37

Характеристика правильного астигматизма: ж-наш

Вертикальный меридиан преломляет сильнее горизонтального.

Преломляющая сила не меняется на протяжении меридиана.

Преломляющая сила меняется на протяжении меридиана.

Горизонтальный меридиан, преломляет сильнее вертикального.

В главных меридианах имеются разные виды аномалии рефракции.

#38

Что характерно для неправильного астигматизма?

Большая разность преломляющей силы главных меридианов.

Изменение преломляющей силы на разных отрезках одного меридиана.

Горизонтальный меридиан преломляет сильнее вертикального.

В главных меридианах имеется один вид аномалий рефракции.

Горизонтальный меридиан преломляет сильнее вертикального.

#39

Что характеризует сложный астигматизм?

Большая разность между рефракцией в главных меридианах.

Разная степень одного вида аметропии в главных меридианах..

Разные виды рефракции в главных меридианах.

Изменение преломляющей силы на протяжении одного меридиана.

Наличие эмметропии в одном из главных меридианов.

#40

Чем характеризуется смешанный астигматизм?

Сочетанием в главных меридианах миопии и гиперметропии.

Изменением преломляющей силы на разных участках одного меридиана.

Большой разницей в преломляющей силе главных меридианов.

Сочетанием в главных меридианах разных степеней одного вида аметропий.

Минимальной разностью рефракции в главных меридианах

#41

При каком виде рефракции сферические собирательные линзы не ухудшают зрение?

Эмметропии

Миопии

Гиперметропии

Смешанном астигматизме

Сложном миопическом астигматизме

#42

Почему степень миопии определяют по самой слабой минусовой линзе?

Рассеивающие линзы не меняют величину изображения на сетчатке

Рассеивающие линзы увеличивают изображение на сетчатке

Гиперкоррекцию миопии глаз устраняет с помощью аккомодации.

Гиперкоррекцию миопии глаз устраняет с помощью дезаккомодации.

Рассеивающие линзы увеличивают размер изображения на сетчатке

#43

При каком состоянии рефракции вращение перед глазом экрана с целью меняет остроту зрения?

При абсолютной аккомодации

При статической рефракции

При динамической рефракции

При астигматизме

При сферической рефракции

#44

При какой рефракции дальнейшая точка ясного зрения находится в 1 метре от глаза исследуемого?

Эмметропии.

Гиперметропии 1,0 Д.

Миопии 0,5 Д

Миопии 1,0 Д.

Миопии 2,0 Д.

#45

Движение тени при скиаскопии с расстояния в 1 метр исчезает при приставлении стекла + 1.0 Д. Какая рефракция у исследуемого?

Эмметропия.

Гиперметропия 2.0 Д.

Миопия 1.0 Д.

Гиперметропия 1,0Д

Миопия 2,0 Д.

#46

В чем причина пресбиопии?

Возрастном уменьшении эластичности хрусталика

Возрастном ослаблении волокон цилиарной мышцы.

Уменьшении показателя преломления хрусталика.

Возрастном ослаблении различительной способности сетчатки
Нарушении прозрачности хрусталика.

#47

При каком виде рефракции раньше всего клинически проявляется пресбиопия?

Не имеет значения.

При гиперметропии

При миопии.

При эметропии.

При астигматизме

#48

Парез, паралич аккомодации возникает при:

Поражении волокон симпатического нерва, иннервирующих цилиарную мышцу

Поражении парасимпатической части глазодвигательного нерва

Поражении блокового нерва

Поражении отводящего нерва

Поражении глазного нерва

#49

Что такое миопический конус?

Прямого типа сложный миопический астигматизм высокой степени

Перипапиллярная хориоретинальная дистрофия

Пятно Фукса

Периферическая хориоретинальная дистрофия

Центральная хориоретинальная дистрофия

#50

Какое лечение называется плеоптическим?

Лечение по развитию фузионных резервов.

Лечение по развитию движений глаз.

Лечение, направленное на повышение остроты зрения.

Лечение, направленное на расширение поля зрения.

Лечение по тренировке аккомодации

#51

Что понимают под дисбинокулярной амблиопией?

Появление дефекта в поле зрения, отмечаемого самим больным.

Ограничение подвижности косящего глаза.

Понижение остроты зрения косящего глаза без патологии глазного дна.

Возникновение двоения

Аномалия корреспонденция сетчаток

#52

Чему равен угол косоглазия, если световой рефлекс расположен по краю зрачка?

15°

20°-25°

30°-35°

45°

меньше 15°

#53

Какой из приведенных признаков характеризует альтернирующее косоглазие?

Косит постоянно один глаз.

Глаза косят попеременно.

Очки исправляют положение глаз.

В очках косоглазие сохраняется.

Развивается амблиопия.

#54

В каком возрасте следует начинать лечение содружественного косоглазия?

В 5 лет.

В 7 лет.

С момента его выявления.

В 10 лет.

В 15 лет.

#55

Какой из приведенных признаков характеризует монолатеральное косоглазие?

Глаза косят попеременно.

Очки исправляют косоглазие.

Косит постоянно один глаз.

В очках косоглазие сохраняется.

Амблиопия не наблюдается.

#56

В каком возрасте предпочтительно оперировать содружественное монолатеральное косоглазие, выявленное с рождения?

До года

2-3 года.

4-5 лет.

7-8 лет.

После 10 лет.

#57

В каком возрасте, как правило, появляется содружественное косоглазие?

С рождения до 2-3 лет

5-6 лет

7-8 лет.

10-12 лет.

15 лет

#58

Хирургическое лечение содружественного косоглазия без вертикального компонента выполняют на :

На четырех прямых глазодвигательных мышцах

На двух прямых мышцах горизонтального действия

На леваторе верхнего века

На круговой мышце глаза

На обеих косых глазодвигательных мышцах

#59

Где расположено слезное озеро?

Во внутреннем углу глазной щели

В наружном углу глазной щели

Под нижней носовой раковиной

Под средней носовой раковиной

В нижнем конъюнктивальном своде

#60

Какой из перечисленных методов можно рекомендовать при дакриоцистите новорожденных до 3-х месячного возраста?

Нисходящий массаж области проекции слезного мешка с инстилляцией дезинфицирующих капель

Промывание слезных путей

Зондирование слезно-носового канала

Закладывание глазной мази за нижнее веко

Операция дакриоцисториностомия

#61

Лечение хронического дакриоцистита заключается в : если 1 ответ то дакрио

Экстирпации слезного мешка

Нисходящем массаже области проекции слезного мешка

Промывании под напором слезных путей

Зондировании слезноносового канала

Дакриоцисториностомии

#62

Какая мышца обеспечивает смыкание век?

Круговая мышца глаза

Леватор верхнего века

Лобная мышца

Мышечная воронка

Верхняя прямая мышца

#63

Что такое базалиома века?

Доброкачественная опухоль кожи век

Базально - клеточный рак кожи

Злокачественная опухоль век, развившаяся из железы хряща века

Разновидность старческой бородавки

Опухоль мезодермального генеза

#64

Поражение какого из черепно-мозговых нервов вызывает лагофтальм?

Глазодвигательного

Лицевого

Отводящего

Блокового

Тройничного

#65

Чем обеспечивается барьерная функция конъюнктивы?

Плотностью и толерантностью конъюнктивы к токсическим веществам

Обилием лимфоидных клеток и аденоидных элементов

Секретом конъюнктивальных желез

Слезотечением при раздражении конъюнктивы

Богатой васкуляризацией конъюнктивы

#66

Какой симптом отличает пневмококковый конъюнктивит от других?

Обильное сливкообразное гнойное отделяемое

Серые пленки на слизистой век, которые легко снимаются и не кровоточат

Серые пленки на конъюнктиве век, которые снимаются с трудом, обнажая кровоточащую конъюнктиву

Отделяемое цвета мясных помоев

Обилие фолликулов в конъюнктиве век и переходных складок

#67

Гонобленнорея имеет особо тяжелое течение у:

Новорожденных

Детей

Взрослых

Нет различий клиники по возрасту пациента

Лиц мужского пола

#68

Что такое симблефарон?

Рост ресниц по направлению к главному яблоку

Заворот век

Сращение конъюнктивы век и глазного яблока

Высыхание конъюнктивы и роговицы

Инфильтрация роговицы с врастающими в нее сосудами

#69

Какой из вариантов ответов соответствует понятию «перикорнеальная инъекция»?

Визуализируются короткие сосуды в лимбальной зоне, придающие краснофиолетовую окраску этой зоне.

В большой степени заинтересованы сосуды конъюнктивы склеры.

В большой степени заинтересованы передние цилиарные сосуды.

Цвет сосудов ярко-красный.

Характерна извитость сосудов конъюнктивы склеры.

#70

Стадию распада инфильтрата роговицы позволяет установить:

Определение чувствительности роговицы

Проба Ширмера

Флюоресцеиновая проба

Начало васкуляризации роговицы

УЗИ

#71

Кератоконус свидетельствует об изменении :

Прозрачности роговицы

Чувствительности роговицы

Сферичности роговицы

Величины роговицы

Толщины роговицы на все протяжении.

#72

В лечении кератомикоза в виде капель и парабульбарных инъекции используются :

Кортикостероиды

Антибиотики

Антидепрессанты

Антимикотические препараты производные имидазола

Антикоагулянты

#73

Лечение бельма роговицы заключается

В назначении антибиотиков местно

В назначении витаминов местно

В назначении кортикостероидов местно

В кератопластике

В назначении антикоагулянтов

#74

В составе какого нерва проходят волокна, иннервирующие сфинктер зрачка?

Отводящего

Глазодвигательного

Тройничного

Лицевого

Блокового

#75

Каким нервом осуществляется чувствительная иннервация радужки?

Глазодвигательным

Лицевым

Симпатическим

Блоковым

Носоресничным

#76

Какой нерв осуществляет чувствительную иннервацию хориоидеи?

Хориоидея не имеет чувствительную иннервацию

Лицевой

Симпатический

Глазной

Глазодвигательный

#77

Как называется воспаление собственно сосудистой оболочки?

Циклит

Ирит

Хориоидит

Панувеит

Периферический увеит

#78

Что такое преципитаты?

Точечные отложения на задней поверхности роговицы

Помутнение стекловидного тела

Точечные помутнения на передней поверхности роговицы

Экссудат в просвете зрачка

Помутнения под передней капсулой хрусталика

#79

Что такое синехии ?

Спайки радужки с хрусталиком или с роговицей

Точечные отложения на задней поверхности роговицы

Плавающие помутнения стекловидного тела

Заращение зрачка

Помутнения в хрусталике

#80

Что такое колобома?

Дополнительные зрачки

Спайки радужки с хрусталиком

Дефект ткани и анатомических элементов глаза

Спайки радужки с роговицей

Опухоль сосудистой оболочки

#81

Что такое увеопатии?

Воспалительные заболевания сосудистой оболочки

Группа дистрофических заболеваний сосудистой оболочки

Заболевания сосудистой оболочки, связанные с общими заболеваниями организма

Доброкачественные новообразования сосудистой оболочки

Злокачественные новообразования сосудистой оболочки

#82

Что такое мидриатики?

Препараты, суживающие зрачок

Препараты, расширяющие зрачок

Препараты, снижающие внутриглазное давление

Препараты трофического действия

Препараты действующие на свертываемость крови

#83

Какой из перечисленных препаратов обладает наиболее сильным мидриатическим эффектом ?

Раствор атропина

Раствор скополомина

Раствор мезатона

Раствор адреналина гидрохлорида

Раствор клофелина

#84

Чем объясняется расширение зрачка при инстилляции атропина и его аналогов?

Параличом сфинктера зрачка

Возбуждением дилататора зрачка

Возбуждением сфинктера зрачка

Инактивацией фермента холинэстеразы

Параличом дилататора зрачка

#85

Как называется состояние, когда в радужке имеется несколько зрачков?

Колобома радужки

Поликория

Задние синехии

Гетерохромия

Гетерофория

#86

Как называется помутнение хрусталика?

Катаракта

Лейкома

Лентиконус

Афакия

Колобома

#87

К какому возрасту формируется ядро хрусталика?

К году

10 лет

20-25 лет

40 лет

60 лет

#88

Какая катаракта, как правило, не прогрессирует?

Врожденная

Возрастная

Рентгеновская

Диабетическая

Травматическая

#89

У больного 30 лет в обоих глазах обнаружена веретенообразная катаракта. К какому виду катаракт Вы ее отнесете?

Врожденной

Приобретенной
Возрастной
Осложнённой
Вторичной

#90

Для какой стадии катаракты характерна глубокая передняя камера?

Перезрелой Морганиевой катаракты

Перезрелой молочной катаракты
Незрелой катаракты
Зрелой катаракты
Начальной катаракты

#91

Если у больного в течение нескольких лет острота зрения левого глаза была равной светоощущению, а в последнее время появилось предметное зрение в 0,02. н.к., то как Вы думаете, с чем это связано?

С переходом в перезрелую Морганиевую катаракту

С неправильной постановкой диагноза катаракты
С возникновением афакии
С переходом в молочную катаракту
Развитием вторичной катаракты

#92

Что такое афакия?

Появление признаков перезревания катаракты

Отсутствие хрусталика

Вывих хрусталика в стекловидное тело
Уменьшенный в размерах шаровидной формы хрусталик

Конусовидное выпячивание у полюса хрусталика

#93

Какое лечение показано больному незрелой катарактой с низкой остротой зрения?

Операция факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ

Назначение мидриатиков и витаминных капель для «просветления» хрусталика и улучшения зрения

Иридэктомия

Ждать до полного созревания катаракты, а затем оперировать

Экстракция катаракты с назначением очков

#94

Что такое афакия?

Состояние глаза после удаления хрусталика

Глаз, с имплантированным искусственным хрусталиком

Вывих хрусталика в стекловидное тело

Аномалия хрусталика

Вывих хрусталика в переднюю камеру

#95

Укажите наиболее совершенный способ коррекции афакии:

Контактная коррекция

Очковая коррекция

Имплантация ИОЛ

Коррекция изейконическими очками

Коррекция телескопическими очками

#96

При диспансерном осмотре у ребенка в обоих глазах обнаружена передняя полярная катаракта. Какое лечение Вы ему рекомендуете?

Экстракция катаракты в возможно раннем возрасте

Лечение не требуется

Экстракция катаракты после 18 лет с имплантацией ИОЛ

Назначить для профилактики прогрессирования катаракты витаминные капли

Назначить мидриатики

#97

При бурой катаракте рано нарушается:

Периферическое зрение

Центральное зрение

Цветовое зрение

Бинокулярное зрение

Темновая адаптация

#98

Какое осложнение возможно при незрелой набухающей катаракте?

Вторичная факолитическая глаукома

Вторичная фактопическая глаукома

Вторичная фактоморфическая глаукома

Иридоциклит

Кератит

#99

Где происходит выработка внутриглазной жидкости?

В радужке

В цилиарном теле

В хориоидее

В стекловидном теле

В хрусталике

#100

Куда после образования в первую очередь поступает внутриглазная жидкость?

В переднюю камеру

В заднюю камеру

В Шлеммов канал

В коллекторные канальцы

В водяные вены

#101

Как называется метод исследования угла передней камеры?

Биомикроскопия

Офтальмоскопия

Гониоскопия

Тонография

Диафаноскопия

#102

Как называется метод изучения гидродинамики глаза?

Тонометрия

Тонография

Гониоскопия

Реография

Электроретинография

#103

Как называется заболевание, где расстройство регуляции офтальмотонуса вызвано другим диагностируемым заболеванием глаза?

Первичная глаукома

Вторичная глаукома

Увеопатия

Панувет

Эссенциальная гипертензия

#104

Как Вы полагаете, что лучше - больного с острым приступом глаукомы, проживающего в хороших условиях, лечить амбулаторно или направить в стационар?

Лечить амбулаторно

Лечить в стационаре после визита к офтальмологу поликлиники

Зависит от желания больного

Направить в центральные глазные клиники

Лечить в стационаре в режиме "cito"

#105

Критерий определения стадии первичной глаукомы:

Показатели гидродинамики глаза

Цифры тонометрического давления

Острота зрения, ретинальная острота зрения

Показатели поля зрения

Эхобиометрия глазного яблока

#106

При каком заболевании картина глазного дна напоминает "раздавленный помидор"?

При непроходимости центральной артерии сетчатки

При непроходимости центральной вены сетчатки

При диабетической ретинопатии

При отслойке сетчатки

При хориоретините

#107

При отслойке сетчатки в верхне-наружном квадранте дефект поля зрения при периметрии локализуется:

В верхне-наружном квадранте

В верхне-нижнем квадранте

В нижне-наружном квадранте

В нижне-внутреннем квадранте

В центральной части сетчатки

#108

Какие жалобы предъявляют больные в ранней стадии пигментной тапето- ретинальной абнотрофии?

На снижение остроты зрения и сужение поля зрения

На гемералопию

Появление летающих мушек перед глазами

Расстройство цветоощущения

На фото и метаморфопсии

#109

Какие элементы на глазном дне характерны для пигментной дистрофии на ранних сроках заболевания?

Пигментные очажки в макулярной и парамаккулярной областях

Крупные полиморфные очаги на средней периферии глазного дна

Очаги типа "Соль и перец" на крайней периферии глазного дна

Пигментные очаги в виде «костных телец» на периферии глазного дна

Твердые эксудаты

#110

Каков прогноз пигментной дистрофии сетчатки?

Благоприятный с полным восстановлением зрительных функций

Удовлетворительный с умеренным снижением центрального зрения

Удовлетворительный с незначительным сужением поля зрения

Неблагоприятный, обуславливающий инвалидизацию в позднем периоде

Удовлетворительный, но с развитием центральной скотомы

#111

Для симптома Салюса – Гунна характерно:

Ретиношизис

Микроаневризмы

Патологический артериовенозный перекрест.

Гиперпигментация

Штопорообразная извилистость премакулярных сосудов

#112

Третья степень симптома Салюса- Гунна диагностируется на основании :

Умеренного давления вены артерией и конического сужения вены по обе стороны артерии

Штопорообразной извилистости премакулярных сосудов

Расширения и дугообразного изгиба вены перед перекрестом

«Прерванности» вены на некотором протяжении по обе стороны от перекреста

Артерии приобретают вид серебряной проволоки

#113

Какова будет тактика амбулаторного офтальмолога при поверхностно расположенном инородном теле на конъюнктиве или роговице?

Направить больного в офтальмологический стационар

Обильно струйно промыть конъюнктивальную полость физиологическим или дезинфицирующим раствором

После анестезии удалить инородное тело ватной «сigaretкой» или «копьем» с инстилляцией дезинфицирующих и витаминных капель, назначив их амбулаторно с повторным осмотром

Назначить внутримышечно антибиотики

Назначить per.os антибиотики

#114

Гнойная инфекция в стекловидном теле при проникающем ранении глаза называется:

Флегмона глазницы

Эндофтальмит

Задняя отслойка стекловидного тела

Нитчатая деструкция стекловидного тела

Зернистая деструкция стекловидного тела

#115

Через верхнюю глазничную щель проходят:

Глазной нерв

Глазодвигательные нервы

Верхняя глазная вена

Глазная артерия

Зрительный нерв

#116

Веки являются:

Придаточным аппаратом органа зрения;

Защитным аппаратом органа зрения;

Слезопродуцирующей системой

Слезоотводящей системой

Глазодвигательным аппаратом

#117

Ветвями глазной артерии являются:

Лицевая артерия;

Слезная артерия;

Центральная артерия сетчатки

Задние длинные и короткие цилиарные артерии

Передние цилиарные артерии

#118

Кровоснабжение век осуществляется :

Мышечными артериями

Передними цилиарными артериями

Ветвями слезной артерии

Ветвями решетчатой артерии

Задними длинными цилиарными артериями

#119

В какой последовательности расположены слои роговицы?

1=Передний эпителий

2=Боуменова мембрана

3=Строма

4=Десцеметова мембрана

5=Эндотелий

#120

Питание роговицы осуществляется за счет:

Краевой петливой сосудистой сети

Задних длинных цилиарных артерий

Задних коротких ресничных артерий

Слезной жидкости

Внутриглазной жидкости

#121

Укажите последовательность расположения слоев сетчатки:

1=Пигментный эпителий

2=Слой фоторецепторов

3=Наружная пограничная мембрана

4=Наружный зернистый слой

5=Наружный сетчатый слой

6=Слой биполяров

7=Внутренний сетчатый слой

8=Слой ганглионарных клеток

9=Слой нервных волокон

10=Внутренняя пограничная мембрана

#122

Склера предназначена для: (если 1 то обеспечения)

Трофики средней и внутренней оболочек глазного яблока

Защиты внутренних структур внутренних оболочек глазного яблока

Преломления света

Обеспечения формы глазного яблока

Аккомодации

#123

Хориоидея состоит из слоев:

Внутреннего сетчатого слоя

Хориокапилляров

Слоя средних и мелких сосудов

Слоя крупных сосудов

Супрахориоидеи

Базальной пластинки

#124

В пределах «мышечной воронки» находятся:

Зрительный нерв

Глазная артерия

Главная слезная железа

Верхняя глазная вена

Первая ветвь тройничного нерва

#125

Стекловидное тело выполняет:

Трофическую функцию

«Буферную функцию»

Оптическую функцию

Функцию аккомодации

Секреторную функцию

#126

Кровоснабжение цилиарного тела и радужки осуществляется:

Задними длинными цилиарными артериями

Задними короткими цилиарными артериями

Решетчатыми артериями

Медиальными артериями век

Передними цилиарными артериями

#127

Центральная артерия сетчатки питает:

Хориоидею

Внутренние слои сетчатки

Наружные слои сетчатки

Склеру

Зрительный нерв

#128

Слои хориоидеи расположены следующим образом:

1=Супрахориоидея

2=Слой крупных сосудов

3=Слой средних и мелких сосудов

4=Слой хориокапилляров

5=Базальная пластинка

#129

Иннервацию глазодвигательных мышц осуществляют:

Глазодвигательный нерв

Отводящий нерв

Блоковый нерв

Глазной нерв

Лицевой нерв

#130

Расположите в должной последовательности слои цилиарного тела:

1=Супрахориоидея

2=Мышечный слой

3=Сосудистый слой

4=Базальная пластинка

5=Пигментный эпителий

6=Беспигментный эпителий

#131

В какой последовательности расположены части зрительных путей?

1=Зрительные нервы

2=Хиазма

3=Зрительные тракты

4=Наружные коленчатые тела

5=Зрительная лучистость

6=Шпорная борозда

#132

Сетчатая оболочка делится на:

Плоскую часть

Отростчатую часть

Цилиарную зону

Слепую часть

Оптически деятельную часть

#133

Что характеризует понятие «острота зрения» ?

Способность воспринимать отдельно две точки с минимальным промежутком на максимальном расстоянии от глаза

Способность глаза четко различать цвета и оттенки

Способность глаза четко различать предмет в центре и на периферии

Пространство одновременно воспринимаемое неподвижным глазом

Минимальный угол зрения, позволяющий воспринимать 2 точки отдельно

#134

В каких единицах измеряется острота зрения?

В относительных единицах ,

В диоптриях

В десятичных дробях

В процентах

В градусах

#135

Есть ли взаимозависимость между углом зрения и остротой зрения? Если да, то какая?

Есть

Прямая

Обратная

Нет

Зависимость переменная

#136

Если у больного имеются непрозрачные среды глаза с отсутствием предметного зрения, можно ли определить,какую следует ожидать остроту зрения после восстановления прозрачности сред? Если да, то каким способом?

Нет

Да

Исследуя светоощущение по проекции света

Методом изучения анамнестических сведений о зрении до помутнения сред

Методом офтальморетинографии

Методом адаптометрии

Путем тщательного функционального исследования второго глаза

Определив ретиальную остроту зрения

#137

Какими качествами характеризуются хроматические цвета?

Цветовым тоном

Насыщенностью

Углом зрения

Яркостью

Оттенком

#138

Какие спектральные цвета относятся к длинноволновым?

Красный

Оранжевый

Желтый

Голубой

Синий

#139

Укажите цветоощущающие компоненты, имеющиеся в зрительном анализаторе, согласно теории Ломоносова:

Красный

Желтый

Зеленый

Синий

Фиолетовый

#140

Происходит ли возбуждение монохромных фоторецепторов лучами другой длины волны?

Нет

Да

Но в меньшей степени

В большей степени

В одинаковой степени

#141

Какие виды аномальной трихромазии Вы знаете?

Протаномалия

Дейтераномалия

Дейтеранопия

Протанопия

Тританомалия

#142

Какие из перечисленных расстройств цветоощущения являются врожденными?

Аномальная трихромазия

Дихромазия

Хлоропсия

Цианопсия

Монохромазия

#143

Какие из перечисленных расстройств цветоощущения являются приобретенными?

Эритропсия

Ксантопсия

Аномальная трихромазия

Дихромазия

Цианопсия

#144

Какое значение имеет поле зрения для жизнедеятельности человека, в медицине, в офтальмологии?

Обеспечивает ориентацию в пространстве

Расстройства поля зрения являются ранним симптомом различных глазных заболеваний

Обеспечивает нормальное цветовосприятие

Характеризует темновую адаптацию

Способствует топической диагностике поражений головного мозга

#145

Из перечисленных методов укажите методы исследования поля зрения:

Адаптометрия

Контрольный метод

Эхоиометрия

Периметрия

Кампиметрия

#146

Какие существуют методики периметрии ?

Автоматическая

Статическая

Квантитативная

Компьютерная

Биометрия

Цветовая (хроматическая)

#147

Существуют ли различия между периметрией и кампиметрией?

Нет

Кампиметрия– метод исследования центральных отделов поля зрения на плоскости

Кампиметрия– метод исследования поля зрения по дуге или сферической поверхности

Периметрия – метод исследования центральных отделов поля зрения на плоскости

Периметрия – метод исследования поля зрения по дуге или сферической поверхности

#148

Какие виды двусторонней гемианопсии Вы знаете?

Гомонимные

Гетеронимные

Очаговые

Битемпоральные

Биназальные

Трубочное поле зрения

#149

Какие изменения будут в полях зрения при повреждении центральных отделов хиазмы?

Битемпоральная гемианопсия

Биназальная гемианопсия

Гомонимная гемианопсия

Гетеронимная гемианопсия

Правосторонняя гемианопсия

#150

Формы гемералопии:

Функциональная

Симптоматическая

Различительная

Абсолютная

Относительная

#151

Что характеризует клиническую рефракцию ?

Преломляющая сила оптической системы глаза.

Положение главного фокуса по отношению к сетчатке

Отношение фокусного расстояния к длине передне-задней оси глаза

Положение дальнейшей точки ясного видения

Положение ближайшей точки ясного видения

#152

Что такое дальняя точка ясного видения и что она характеризует?

Наиболее удаленная точка от глаза, видимая при покое аккомодации.

Наиболее удаленная от глаза точка, видимая при напряжении аккомодации.

Характеризует физическую рефракцию глаза.

Характеризует клиническую рефракцию, статическую.

Характеризует клиническую рефракцию, динамическую

#153

Что такое астигматизм?

Разная рефракция обоих глаз

Сочетание разных степеней одного вида рефракции в одном глазу

Разная величина изображения предмета на сетчатках.

Высокая степень аметропии

Сочетание разных видов рефракции в одном глазу

#154

Укажите виды астигматизма

Прямой.

Обратный.

Простой.

Сложный.

Смешанный.

#155

Что такое главные меридианы астигматического глаза?

Плоскости, где имеется наибольшая разница в преломляющей силе

Плоскости с наименьшей разницей преломляющей силы.

Сечения, расположенные под острым углом

Сечения, расположенные под прямым углом

Сечения, расположенные под тупым углом

#156

Определите характеристики астигматизма, если в вертикальном меридиане эмметропия, в горизонтальном гиперметропия

Простой.

Сложный.

Прямой.

Обратный.

Физиологический

#157

Дайте характеристику астигматизма, где в вертикальном меридиане рефракция $H\ 3.5$ диоптрии, а в горизонтальном $H\ 1.0$ диоптрия

Простой.

Сложный.

Смешанный.

Прямой.

Обратный

#158

Дайте характеристику астигматизма, где рефракция вертикального меридиана М 4.5 диоптрии, а горизонтального Н 2,0 диоптрии

Простой.

Сложный.

Смешанный.

Прямой

Обратный

Правильный.

#159

Укажите вид и степень рефракции, если одинаково хорошее зрение получено со стеклами -1.0, -2.0, -3.0 Д

Эмметропия

Миопия

1,0Д

2,0Д

3,0Д

#160

Укажите вид и степень рефракции, если одинаково хорошее зрение получено со стеклами +1.0, +1.5, +2.0 Д

Эмметропия

Миопия

Гиперметропия

1,0Д

1,5Д

2,0Д

#161

Укажите объективные методы определения рефракции

Аккомодометрия.

Скиаскопия

Авторефрактометрия.

Офтальмометрия

Лазеррефрактометрия

#162

С какой целью скиаскопия осуществляется после инстилляций циклоплегиков?

При расширенном зрачке лучше видно движение тени

Для паралича аккомодации.

Для устранения спазма аккомодации

Для исследования динамической рефракции

Для определения статической рефракции

#163

Какими из приведенных препаратов можно добиться циклоплегии?

Атропином

Пилокарпином

Мидриацилом

Цикломедом

Адреналином

#164

Запас аккомодации – это?

Абсолютная аккомодация

Относительная аккомодация

Положительная часть относительной аккомодации

Объем абсолютной аккомодации

Отрицательная часть относительной аккомодации

#165

Критерии прогрессирования миопии:

Увеличение степени миопии в динамике

Ухудшение показателей аккомодации в динамике

Возникновение гетерофории

Нарушение баланса между аккомодацией и конвергенцией

Рост биометрических показателей глазного яблока

Появление или увеличение хориоретинальных дистрофий

#166

Клинические состояния как осложнения миопии:

Катаракта

Увеопатии

Деструкция и отслойка стекловидного тела

Хориоретинальные дистрофии

Отслойка сетчатки

Атрофия зрительного нерва

#167

Перечислите условия, необходимые для наличия бинокулярного зрения:

Острота зрения худшего глаза не ниже 0,3-0,4.

Отсутствие ограничения поля зрения.

Изейкония.

Ортофория.

Проекция изображения на диспаратных точках сетчаток.

Способность к фузии.

Анизейкония.

#168

Перечислите консервативные методы лечения содружественного косоглазия:

Очковая коррекция после циклоплегии

Плеоптическое лечение.

Ортоптическое лечение.

Диплоптическое лечение.

Медикаментозное лечение.

#169

Что такое гетерофория и как ее выявить?

Мнимое косоглазие.

Скрытое косоглазие.

Характер зрения - бинокулярный.

Характер зрения - монокулярный.

Появление установочного движения по снятии окклюзии с "косящего" глаза.

#170

Виды плеоптического лечения:

Прямая окклюзия.

Пенализация.

Засвет центральной ямки сетчатки ярким светом.

Развитие фузионных резервов на синоптофоре.

Тренировка цилиарной мышцы.

Оптическая коррекция зрения

#171

Выберите признаки содружественного косоглазия:

Сохранение полного объема движений глазных яблок.

Наличие диплопии.

Неравенство первичного и вторичного углов косоглазия.

Ограничение подвижности косящего глаза.

Равенство первичного и вторичного углов косоглазия.

Отсутствие диплопии

#172

Что характерно для аккомодационного косоглазия?

При ношении очков косоглазие сохраняется.

Больной жалуется на диплопию.

Ношение очков устраняет косоглазие.

Снижение остроты зрения косящего глаза.

Ограничение подвижности глазных яблок.

На период атропинизации косоглазие устраняется.

#173

Выберите признаки паралитического косоглазия:

Сохранение полного объема движений глаз.

Наличие диплопии.

Неравенство первичного и вторичного углов косоглазия.

Ограничение подвижности косящего глаза.

Отсутствие диплопии.

Равенство первичного и вторичного углов косоглазия.

#174

Родители ребенка 5 лет обратились с жалобами на то, что ребенок косит. Составьте план обследования:

1=Сбор анамнеза.

2=Исследование аккомодации

3=Исследование поля зрения

4=Оценка офтальмологического статуса с исследованием характера зрения.

5=Подбор очков после циклоплегии.

#175

Назначьте лечение ребенку, 3-х лет. Диагноз: содружественное сходящееся монолатеральное неаккомодационное косоглазие, гиперметропия средней степени, амблиопия левого глаза.

Ортоптическое лечение.

Постоянное ношение очков.

Прямая окклюзия, плеоптическое лечение, диспансерное наблюдение.

Тренировка цилиарной мышцы.

Хирургическое лечение в данном возрасте

#176

Укажите методы исследования характера зрения:

Демонстрация опто типов с расстояния 5 метров.

Периметрия.

Проба Соколова, чтение с карандашом, проба со спицами.

Рефрактометрия.

Исследование на 4-х точечном цветотесте Белостоцкого.

#177

Выберите виды деятельности, которые противопоказаны при отсутствии бинокулярного зрения

Военные.

Учитель.

Врач-хирург, стоматолог, медицинская сестра,

Работник транспорта, монтажник

Часовщик.

Работник торговли

#178

Бинокулярное зрение характеризуется:

Пространственным зрением

Стереоскопическим зрением

Цветовым зрением

Глубинным зрением

Контрастной частотой слияния мелькания

#179

Монокулярное зрение даёт информацию:

О взаиморасположении предметов

О высоте предмета

О ширине предмета

О третьем измерении предмета (объемности)

О форме предмета

#180

Угол косоглазия может быть определен:

Опытом со спицами

Опытом Соколова

Способом Гиршберга

На синоптофоре

На 4х точечном цветотесте

#181

Какие из перечисленных мышц иннервируются глазодвигательным нервом?

Верхняя прямая мышца

Нижняя прямая мышца

Верхняя косая мышца

Наружная прямая мышца

Нижняя косая мышца

Внутренняя прямая мышца

#182

Укажите причины слезотечения.

Ячмень

Выворот нижней слезной точки, выворот нижнего века

Воспаление слезных канальцев, слезного мешка

Блефарит

Гипертрофия нижней носовой раковины

Сужение или заращение слезно-носового канал

#183

Расставьте по порядку номеров путь эвакуации слезы из конъюнктивальной полости:

1=Слезное озеро

2=Слезные точки

3=Слезные канальцы

4=Слезный мешок

5=Слезно-носовой канал

6=Нижний носовой ход

#184

Какие препараты применяются для окрашивания слезы в диагностических целях?

Раствор колларгола

Раствор флюоресцеина

Раствор перфторана

Раствор бриллиантового зеленого

Раствор метиленовой сини

#185

Укажите характерные признаки острого дакриoadенита.

Боль, гиперемия и отек в верхне-наружной части орбиты и наружной половины верхнего века

Боль, гиперемия отек в нижне-внутренней части орбиты

Смещение глазного яблока книзу и кнутри

Смещение глазного яблока кверху и кнаружи

Увеличение и болезненность предушной лимфатической железы, лихорадка

#186

Что является причиной дакриоцистита новорожденных?

Конъюнктивит

Атрезия нижнего конца слезно-носового канала

Атрезия слезных точек

Атрезия слезных канальцев

Сохранность эмбриональной мембраны у нижнего конца слезно-носового канала в постнатальном периоде

#187

Лечение дакриоцистита новорожденным детям возраста 3 месяца-2 года включает:

Нисходящий массаж области проекции слезного мешка

Промывание слезных путей

Зондирование слезно-носового канала с последующим промыванием слезных путей

Дакриоцисториностомию

Экстирпацию слезного мешка

#188

Экзофтальм возникает при:

Увеличении объема орбиты из-за расхождения костных отломков

Снижении тонуса симпатической нервной системы

При заболеваниях щитовидной железы

Атрофии ретробульбарной клетчатки

Новообразованием орбиты

Выстоянии в полость орбиты костных отломков

#189

Клинические признаки тиреотоксического экзофтальма :

Западение глазного яблока

Выстояние глазного яблока

Расширение глазной щели

Блефароспазм

Симптом Греффе

#190

При отечном экзофтальме дополнительно к тиреотоксическому добавляются

Увеличение объема экстраокулярных мышц

Атрофия экстраокулярных мышц

Ограничение подвижности глазных яблок

Отслойка сетчатки

Кератит, застойный сосок зрительного нерва

#191

Укажите клинические признаки тенонита:

Чувство давления в глазнице, боли

Энофтальм

Экзофтальм, диплопия

Оттек век, хемоз

Обильное отделяемое конъюнктивы

#192

Синдром верхней глазничной щели включает:

Экзофтальм

Энофтальм

Офтальмоплегия

Мидриаз, паралич аккомодации

Миоз, спазм аккомодации

Гипостезию, анестезию, кожи век, лба, роговицы

#193

Как иннервируется мышца, поднимающая верхнее веко?

Глазодвигательным нервом

Лицевым нервом

Симпатическая иннервация

Отводящим нервом

Блоковым нервом

#194

Укажите разновидности отека век:

При патологии почек

Аллергический

При гипертонической болезни, сахарном диабете

Воспалительный

Травматический

#195

Из приведенных признаков укажите признаки, отличающие воспалительный отек век от невоспалительного:

Цвет кожи не изменен

Покраснение кожи век

Локальное повышение температуры кожи

Болезненность при пальпации

При пальпации болезненности нет

#196

Укажите характерные признаки ангионевротического отека Квинке:

В развитии процесса имеет значение аллергическая реакция

Кожа гиперемирована

Цвет кожи не изменен

Выраженная болезненность

Болезненности нет

#197

Какие жалобы характерны для больного с любой формой блефарита?

Покраснение краев век

Зуд в глазах, учащенное мигание

Астенопические жалобы

Острая боль в глазу

Гнойное отделяемое в конъюнктивальной полости

#198

Из приведениях симптомов укажите характерные для простого блефарита:

Умеренное покраснение краев век

Наличие пенистого отделяемого в конъюнктивальной полости

У корней ресниц на коже отмечаются отрубевидные чешуйки

У корней ресниц по краю век гнойные корочки

Утомляемость при зрительной работе вблизи, зуд

#199

Из приведенных симптомов укажите характерные для чешуйчатого блефарита:

Умеренное покраснение краев век

Края век постоянно гиперемированы и утолщены

У корней ресниц на коже отмечаются отрубевидные чешуйки

У корней ресниц по краю век гнойные корочки

Учащенное мигание, зуд в глазах, зрительная «утомляемость»

#200

Укажите причины возникновения абсцесса века:

Травма кожи века

Ячмень, фурункул века

Переход воспаления с пограничных областей, метастаз из септического очага

Чешуйчатый блефарит

Колобома века

#201

Из перечисленных новообразований века укажите доброкачественные, развивающиеся из эпителиальной ткани:

Липома

Папиллома

Старческие бородавки

Аденома слезной железы, потовой железы

Фиброма

#202

Из перечисленных новообразований век выберите доброкачественные мезодермального генеза:

Липома

Базалиома

Фиброма

Гемангиома

Нейрофиброма

#203

Из приведенных новообразований век укажите злокачественные эпителиального генеза:

Базальноклеточный рак

Плоскоклеточный рак

Нейрофиброма

Фиброма

Аденокарцинома

#204

Из перечисленных симптомов укажите характерные для лагофтальма:

Глазная щель на стороне поражения шире

Глазная щель на стороне поражения уже

Нижнее веко не прилежит к главному яблоку, слезотечение

Отмечается опущение верхнего века

Глазная щель не смыкается, остается открытой во время сна

#205

Укажите причины птоза верхнего века:

Паралич или парез глазодвигательного нерва

Парез или паралич лицевого нерва

Поражение шейного симпатического нерва

Поражение блокового нерва

Недоразвитие леватора верхнего века

#206

Какие функции выполняет конъюнктива?

Оптическую

Защитную

Увлажняющую

Барьерную

Трофическую

#207

Какие жалобы характерны для острого бактериального конъюнктивита?

чувство инородного тела в глазу, слезотечение, болезненность, зуд

Склеивание век по утрам

Наличие гнойного отделяемого из глаза

Боль в глазу с иррадиацией в различные области

Резкое снижение зрения

#208

Как изменяется конъюнктива при остром бактериальном конъюнктивите?

Конъюнктива век резко гиперемирована

Конъюнктива имеет синюшный оттенок

Наиболее интенсивная гиперемия конъюнктивы склеры

Конъюнктива век отечна, рисунок желез хряща не виден

Рисунок желез хряща век хорошо просматривается

#209

Какие осложнения возможны при гонобленнорее?

Гнойная язва роговицы с расплавлением и перфорацией роговицы, бельмо роговицы

Эндофтальмит, панофтальмит

Рубцовый заворот век

Выворот век

Пемфигус

#210

Какие осложнения возможны при гонобленнорее?

Гнойная язва роговицы с расплавлением и перфорацией роговицы, бельмо роговицы

Эндофтальмит, панофтальмит

Рубцовый заворот век

Выворот век

Пемфигус

#211

Из перечисленных признаков отберите симптомы, чаще наблюдаемые при гонококковом конъюнктивите у взрослых, чем у новорожденных:

Чаще поражается один глаз

Сопровождается лихорадочным состоянием

Нарушение сердечной деятельности

Пневмония

Поражение суставов, мышц

#212

Какие меры применяются для профилактики гонобленнорей у новорожденных?

Тщательное и многократное обследование женщин в период беременности, лечение женщин, больных гонореей

Новорожденным протирают веки тампоном с 2%раствором борной кислоты

В глаза закапывают 2%раствор нитрата серебра однократно

Троекратная в течение часа инстиляция свежеприготовленных растворов антибиотиков или альбумида

В глаза закапывают физиологический раствор

#213

Какие симптомы отличают острый эпидемический конъюнктивит КохаУикса от других бактериальных конъюнктивитов?

Высокая контагиозность, массовые поражения людей в коллективах, населенном пункте

Петехиальные кровоизлияния в конъюнктиве глазного яблока

Серые пленки на конъюнктиве век

В пределах открытой глазной щели у лимба видны серые отечные треугольники

Отделяемое из глаз цвета мясных помоев

#214

Какие из перечисленных симптомов отличают дифтерийный конъюнктивит от других бактериальных конъюнктивитов?

В конъюнктиве множественные петехиальные кровоизлияния

Высокая температура тела, выраженные явления интоксикации, увеличение лимфоузлов

Веки отечные, с цианозом, плотные, отделяемое мутное с хлопьями

На краях век и конъюнктиве плотные серые пленки, после удаления которых конъюнктив кровоточит

На конъюнктиве обнаруживаются серые легко снимаемые пленки

#215

Какие осложнения наблюдаются при дифтерии конъюнктивы?

Грубые звездчатые рубцы на конъюнктиве, рубцовый заворот век, симблефарон

Язва роговицы, перфорация роговицы

Лагофтальм

Эндофтальмит

Гидрофтальм

#216

Из приведенных нозологических форм укажите конъюнктивиты бактериального происхождения:

Фарингоконъюнктивальная лихорадка

Острый эпидемический конъюнктивит Коха-Уикса

Трахома

Гонобленнорея

Дифтерийный конъюнктивит

Пневмококковый конъюнктивит

#217

Из перечисленных конъюнктивитов выберите конъюнктивиты вирусной этиологии:

Фарингоконъюнктивальная лихорадка

Острый эпидемический конъюнктивит Коха-Уикса

Эпидемический кератоконъюнктивит, эпидемический геморрагический конъюнктивит

Гонобленнорея

Герпетический конъюнктивит

#218

Какие из перечисленных воспалений конъюнктивы имеют хламидийную природу?

Трахома

Пемфигус

Острый эпидемический конъюнктивит Коха- Уикса

Паратрахома

Фаринго-конъюнктивальная лихорадка

#219

Из приведенных препаратов выберите применяемые при вирусных конъюнктивитах:

Антибиотики

Флореналь, оксалин

Раствор дезоксирибонуклеазы

Лейкоцитарный интерферон, офтальмоферон, полудан

Раствор дексаметазона

Окомистин

#220

Из перечисленных признаков отберите симптомы эпидемического геморрагического конъюнктивита:

Острое начало

Начало заболевания медленное, клиническая картина скудная

Наличие фолликулов на нижней переходной складке конъюнктивы, незначительное отделяемое

Отделяемое обильное

Большое количество мелких и крупных кровоизлияний в конъюнктиве

#221

Осложнения трахомы:

Кератоконус

Трихиаз

Лагофтальм

Энтропион, симблефарон

Паренхиматозный ксероз роговицы

#222

В чем принципиальное отличие второй стадии трахомы от первой?

В увеличении количества зрелых фолликулов

В появлении рубцов в конъюнктиве век

В уменьшении количества зрелых фолликулов

В отсутствии признаков рубцевания

В развитии паннуса

#223

Из приведенных препаратов выберите для лечения весеннего катара:

Антигистаминные

Антибиотики

Мидриатики

Кортикостероиды

Сульфаниламиды

#224

К признакам кератитов относятся следующие:

Наличие гнойного отделяемого в конъюнктивальной полости

Боль в глазу, светобоязнь, слезотечение, блефароспазм

Наличие перикорнеальной инъекции.

Роговица сохраняет прозрачность.

Роговица отечна, инфильтрирована.

#225

Исходом перенесенного кератита может быть:

Полное восстановление структуры, свойств роговицы и исходной остроты зрения.

Поверхностное помутнение роговицы типа «облачка».

Более глубокое помутнение роговицы типа «пятна».

Помутнение всех слоев роговицы - бельмо.

Микрокорнеа, мегалокорнеа

Кератоконус

#226

С какой целью проводится операция кератопластики?

С целью профилактики прогрессирования близорукости.

С оптической целью

С лечебной целью.

С косметической целью

С тектонической целью

С мелиоративной целью

#227

Какая клиническая картина характерна для ползучей язвы роговицы?

Края язвы ровные, гладкие, одинаковые на всем протяжении.

Язва очищается с регенерацией эпителия и с восстановлением прозрачности роговицы или помутнением типа "nubecula"

Язва склонна к быстрому прогрессированию, один край язвы приподнят и подрыв, противоположный очищается и покрывается эпителием.

Язва может приводить к перфорации роговой оболочки с развитием эндофтальмита.

Имеют место гипопион и клиника иридоциклита.

#228

Какая клиническая картина характерна для древовидного герпетического кератита?

В эпителии роговицы имеются группы мелких пузырьков и инфильтратов, формирующих фигуру веточки.

Кератит часто рецидивирует, трудно поддается лечению.

Течение кератита с преимущественным поражением глубоких слоев роговой оболочки, выражена глубокая васкуляризация роговицы.

Кератит с поражением конъюнктивы и обильным гнойным отделяемым.

Васкуляризация роговицы слабо выражена или отсутствует.

Чувствительность роговицы снижена значительно, вплоть до отсутствия.

#229

Укажите, что из перечисленного соответствует физиологическим свойствам роговицы?

Роговица обладает прозрачностью, зеркальностью, сферичностью

В роговице имеется широко разветвленная сеть кровеносных сосудов.

Роговица обладает высокой чувствительностью.

Роговица является слабой преломляющей средой глаза.

Роговица лишена чувствительности.

Роговица является самой сильной оптической средой глаза.

#230

Что характерно для кератитов?

Наличие гнойного отделяемого

Нарушение прозрачности роговицы, изменение чувствительности.

Слезотечение, светобоязнь, болевой синдром, перикорнеальная инъекция.

Несмыкание глазной щели.

Васкуляризация роговицы.

#231

К объективным симптомам кератитов относятся:

Преципитаты на задней поверхности роговицы.

Наличие перикорнеальной инъекции.

Наличие инфильтрата роговицы, обуславливающего нарушение ее прозрачности.

Появление в роговице новообразованных сосудов.

Миоз.

#232

Что из указанных фармакологических средств следует использовать в лечении эрозии роговицы?

Инстилляции болеутоляющих средств.

Инстилляции и глазные мази антибиотиков, сульфаниламидных препаратов.

Инстилляции кортикостероидов.

Инстилляции кератопластических средств, витаминов, закладывание в конъюнктивальную полость кератопластических желе или мазей.

Инстилляции противовирусных средств и интерферонов

#233

Возможным исходом ползучей язвы роговицы могут быть следующие :

Мегалокорнеа

Глубокое помутнение роговой оболочки – бельмо.

Локальное поверхностное помутнение роговицы категории «облачка».

Перфорация роговицы с развитием эндофтальмита или панофтальмита

Образование бельма роговицы, сращённого с радужкой.

#234

С чем следует дифференцировать кератит?

С острым конъюнктивитом.

С острым кератоконусом.

С иридоциклитом.

С язвенным блефаритом.

С острым дакриoadенитом.

#235

В клинической картине туберкулезно-аллергического кератита особенно сильно выражены:

Слезотечение

Зуд

Светобоязнь

Наличие слизисто-гнойного отделяемого

Блефароспазм

Васкуляризация роговицы глубокая.

#236

Укажите стадии кератита:

Незрелая

Инфильтрат

Распад инфильтрата

Изъязвление

Фасетка

Терминальная

#237

Особенности клинической картины нейропаралитического кератита:

Выраженная светобоязнь

Чувствительность роговицы отсутствует

Слезотечение

Сильный болевой синдром

Отсутствуют светобоязнь, слезотечение

#238

Выберите из перечисленного признаки корнеального синдрома:

Светобоязнь, слезотечение, боль

Перикорнеальная инъекция

Преципитаты

Миоз

Блефароспазм

#239

По классификации кератиты подразделяются на:

Экзогенные

Незрелые

Эндогенные

Развитые

Невыясненной этиологии

#240

Для каких клинических форм кератитов характерно наличие гипопиона?

Туберкулезно – аллергического кератита

Ползучей язвы роговицы

Краевого кератита

Грибкового кератита

Дисковидного кератита.

#241

Гематогенные туберкулезные кератиты подразделяются на:

Древовидный

Глубокий инфильтрат роговицы

Дисковидный

Глубокий диффузный кератит

Склерозирующий кератит

#242

Укажите составные части сосудистой оболочки:

Радужная оболочка

Боуменова мембрана

Цилиарное тело

Десцеметова мембрана

Хориоидея

#243

Какие мышцы расположены в радужной оболочке?

Сфинктер зрачка

Дилататор зрачка

Мышца Мюллера

Мышца Брюкке

Мышца Иванова

#244

Какая иннервация аккомодационной мышцы ?

Глазодвигательным нервом

Отводящим нервом

Блоковым нервом

Симпатическая иннервация

Тройничным нервом

#245

Какие артерии образуют сосуды радужки и цилиарного тела?

Задние короткие цилиарные артерии

Передние цилиарные артерии

Задние длинные цилиарные артерии

Центральная артерия сетчатки

Краевая петлистая сеть

#246

Какие функции выполняет цилиарное тело?

Регулирует количество света, поступающего в глаз

Выработку внутриглазной жидкости

Обеспечивает питание сетчатой оболочки

Активный компонент аккомодации

Активный компонент дезаккомодации

#247

Из перечисленных симптомов выберите кардинальные признаки ирита:

Боль в глазу

Боль в соответствующей половине головы

Смешанная инъекция

Миоз

Мидриаз

Изменение цвета и ступенчатость рисунка радужки

#248

Объективные признаки циклита:

Смешанная инъекция глазного яблока

Изменение цвета и рисунка радужки, миоз

Появление экссудата в стекловидном теле

Преципитаты

Мидриаз

#249

Укажите признаки центрального хориоретинита:

Боль в глазу

Снижение зрения

Фотопсии, метаморфопсии

Задние синехии

Миоз

#250

Какие из перечисленных симптомов свидетельствуют, что к ириту присоединился циклит?

Смешанная инъекция

Преципитаты

Миоз

Усиление боли при пальпации области проекции цилиарного тела

Экссудат в стекловидном теле

#251

Какие осложнения увеитов Вы знаете?

Лентовидная дегенерация роговицы

Катаракта

Вторичная глаукома

Атрофия (субатрофия) глазного яблока

Вывих хрусталика в стекловидное тело

#252

Какие из перечисленных препаратов применяются для лечения иридоциклита?

Анальгетики

Миотики

Мидриатики

Антикоагулянты

Противовоспалительные препараты

#253

Каков механизм действия кортикостероидов при лечении увеитов?

Неспецифическое противовоспалительное

Десенсибилизирующее

Мидриатическое

Гипотензивное

Трофическое

#254

Лечение переднего увеита в первую очередь следует начинать с...

С инстилляций мидриатиков

Выяснения этиологии увеитов

Противовоспалительного лечения

Применения анальгетиков

Гипотензивной терапии

#255

Чем объясняется благоприятное действие мидриатиков при иридоциклитах?

Созданием покоя радужке и цилиарному телу

Уменьшением гиперемии передней части сосудистой оболочки

Профилактикой катаракты

Профилактикой образования задних синехий, сращения и заращения зрачка

Выраженным десенсибилизирующим и антимикробным действием

#256

Как можно усилить мидриатическое действие атропина при иридоциклите?

Инъекцией под конъюнктиву 0.1%раствора адреналина

Инъекцией под конъюнктиву 1%раствора мезатона

Сочетанием инстилляций 1%раствора пилокарпина

Сочетанием инстилляций или субконъюнктивальных инъекций кортикостероидов

Электрофорезом смеси фибринолизина, адреналина

#257

Из перечисленных новообразований сосудистой оболочки укажите доброкачественные:

Меланома

Нейрофиброма

Леймиома

Киста

Невус

#258

Какие из перечисленных методов используются для диагностики опухолей сосудистой оболочки?

Биомикроскопия, гониоскопия, офтальмоскопия

Офтальмометрия, рефрактометрия

Диафаноскопия

Ультразвуковая диагностика

Компьютерная томография орбиты

Радиоизотопная диагностика, флюоресцентная ангиография

#259

Какие из перечисленных методов исследования используют для диагностики переднего увеита?

Офтальмоскопию

Метод бокового освещения, биомикроскопию

Исследование проходящим светом

УЗИ

Оценка формы зрачка на фоне медикаментозного мидриаза

#260

Какие из перечисленных методов исследования используют для диагностики хориоретинита?

Метод бокового освещения

Исследование проходящим светом

Периметрию

Офтальмоскопию

Оптическую когерентную томографию сетчатки

Электроретинографию

#261

Экзогенные увеиты - следствие:

Токсоплазмоза

Бруцеллеза

Травмы глаза

Фокальных инфекций

Операции на глазном яблоке

#262

Причиной эндогенных увеитов может быть:

Туберкулез

Ревматизм

Травма глаза

Аллергические и аутоиммунные процессы

Операции на глазном яблоке

Бруцеллез

#263

Какие клинические состояния классифицируются как увеопатии?

Болезнь Бехчета

Синдром Фукса

Рубеоз радужки

Эссенциальная мезодермальная дистрофия радужки

Глаукомоциклитический криз

#264

Клиническая картина болезни Бехчета складывается из увеита с :

Артритом межпозвонковых и периферических суставов

Уретритом, полиартритом, конъюнктивитом

Афтозно-язвенным стоматитом

Гранулематозом трахеобронхиальных узлов, периферических лимфоузлов

Поражением кожи, язвами наружных половых органов

#265

При глаукомоциклитическом кризе имеют место:

Метаморфопсии

Высокие цифры внутриглазного давления, болевой синдром

Отек роговицы

Мидриаз

Преципитаты

#266

Благодаря чему обеспечивается прозрачность хрусталика?

Стабильности состава камерной влаги

Избирательной проницаемости капсулы хрусталика

Особой структуре и строгой упорядоченности хрусталиковых белков

Стабильности биохимического состава стекловидного тела

Наличию субкапсулярного эпителия

#267

Меняется ли с возрастом содержание воды в хрусталике и как?

Да

Нет

Уменьшается

Остается неизменным

Увеличивается

#268

Какие из перечисленных методов позволяют наиболее полно исследовать хрусталик?

Фокальное освещение

Биомикроскопия

Проходящим светом

Эхоскопия, эхография

Офтальмоскопия

Компьютерная томография орбиты

#269

Чем отличаются врожденные катаракты от приобретенных?

Врожденные катаракты, как правило, прогрессируют

Врожденные катаракты, как правило, не прогрессируют

Приобретенные катаракты, как правило, прогрессируют

Приобретенные катаракты не прогрессируют

Различий нет

#270

Какие формы возрастных катаракт Вы знаете?

Передняя полярная

Задняя полярная

Ядерная, бурая

Веретенообразная

Корковая, серая

Зонулярная

#271

Наиболее частые причины врожденных катаракт:

Нарушение углеводного и кальциевого обмена

Сифилис беременной

Туберкулез беременной

Краснуха беременной

Наследственная предрасположенность

#272

Укажите стадии возрастной катаракты:

Начальная

Незрелая

Стадия фасетки

Зрелая

Терминальная

Перезрелая

#273

Выберите признаки, характерные для начальной стадии катаракты:

Острота зрения снижена до сотых долей

Острога зрения больше 0,5

Передняя камера средней глубины

В проходящем свете в просвете зрачка видны спицеобразные помутнения

При боковом освещении тени от радужки нет

#274

Укажите признаки незрелой катаракты:

Глубина передней камеры уменьшена

Передняя камера глубокая

Острота зрения ниже 0,1 но сохраняется предметное зрение

Нет предметного зрения

В проходящем свете рефлекс с глазного дна отсутствует на узкий зрачок

#275

Укажите признаки зрелой катаракты:

Острота зрения равна светоощущению с правильной проекцией света

Острота зрения не меньше 0,01

Передняя камера мелкая

При исследовании проходящим светом с глазного дна рефлекс отсутствует на широкий зрачок

Тени от радужки нет

#276

Какие этапы перезрелой катаракты Вы знаете?

Вторичная катаракта

Молочная катаракта

Осложненная катаракта

Лентиконус

Морганиева катаракта

#277

Чем характеризуется Морганиева катаракта?

Передняя камера глубокая

Острота зрения - светоощущение с неправильной проекцией света

Восстанавливается предметное зрение

Видно смещенное книзу ядро хрусталика

С глазного дна местами виден розовый рефлекс

#278

Может ли быть афакичный глаз без коррекции эмметропическим, если да, то при какой исходной рефракции?

Да

Нет

При гиперметропии

При высокой миопии

При исходной эмметропии

#279

Какие состояния могут вызвать осложненную катаракту?

Неврит зрительного нерва

Застойный сосок

Увеиты

Увеопатии

Дистрофии сетчатки

Высокая миопия

#280

И роговица, и хрусталик – оптические среды глаза. В чем отличие хрусталика от роговицы?

Хрусталик относится к содержимому (ядру) глазного яблока

Трофика хрусталика осуществляется внутриглазной жидкостью и кровеносной системой

Трофической средой хрусталика является только внутриглазная жидкость

В хрусталике нет нервов и кровеносных сосудов

Хрусталик может менять оптическую силу в довольно широком диапазоне

Хрусталик обладает высокой чувствительностью

#281

Какие осложнения возможны при катарактах?

Факолитическая глаукома

Факоморфическая глаукома

Увеопатии

Дистрофии сетчатки.

Кератит

#282

Вторичная катаракта может развиваться после:

Антиглаукоматозных операций

Экстракапсулярной экстракции катаракты

Кератопластики

Интракапсулярной экстракции катаракты

Склеропластики

#283

Какие виды врожденных катаракт различают?

Передняя и задняя полярные

Зонулярная

Вторичная

Молочная

Веретенообразная

Тотальная

#284

При каких формах врожденных катаракт показано ранняя (до 3-6 месяцев возраста ребенка) операция?

Передней и задней полярной катаракте

Полной, полурассосавшейся катаракте

Центральной (ядерной) катаракте

Зонулярной катаракте с диаметром помутнения менее 3-х мм

Зонулярной катаракте с диаметром помутнения более 3-х мм

При всех формах врожденных катаракт с ригидным зрачком

#285

Офтальмологический статус при афакии:

Передняя камера мелкая

Передняя камера глубокая

Зрачок деформированный, широкий

Отмечается дрожание радужки

При исходной эметропии рефракция будет гиперметропия высокой степени

При исходной эметропии рефракция будет миопической

#286

Расставьте по порядку номеров путь внутриглазной жидкости от момента ее образования до удаления из глаза:

1=Задняя камера

2=Через зрачок в переднюю камеру

3=Угол передней камеры

4=Трабекула

5=Шлемов канал

6=Коллекторные канальцы

7=Интраклеральные вены

8=Эписклеральные вены

#287

С помощью каких методов выявляются дефекты поля зрения?

Офтальмометрии

Периметрии

Визометрии

Эхобиометрии

Кампиметрии

#288

С помощью какого метода можно выявить дистрофические изменения радужной оболочки?

Биомикроскопии

Офтальмоскопии

Фокального (бокового) освещения

Скиаскопии

Исследования проходящим светом

#289

С помощью какого метода можно определить наличие экскавации зрительного нерва?

Офтальмоскопии

Гониоскопии

Периметрии

Оптической когерентной томографии сетчатки

Биомикроскопии

#290

Показатели гидродинамики глаза:

Эластотонметрические параметры

Минутный объем камерной влаги

Коэффициент легкости оттока

Отношение утреннего и вечернего ВГД

Давление оттока

Истинное ВГД

Коэффициент Беккера

#291

Какие типы глауком Вы знаете?

Первичная

Вторичная

Открытоугольная

Закрытоугольная

Врожденная

Эссенциальная гипертензия

#292

Чем отличается глаукоматозная экскавация зрительного нерва от физиологической?

Физиологическая экскавация достигает краев диска

Глаукоматозная экскавация никогда не доходит до края диска

Глаукоматозная экскавация доходит до края диска

При физиологической экскавации диск серого цвета

При глаукоматозной экскавации цвет диска серый или зеленоватый

#293

Как проявляются самые ранние изменения функциональной способности глаза при глаукоме?

Снижением центрального зрения

Концентрическим сужением поля зрения

Расстройством цветоощущения

Парацентральной скотомой

Умеренным сужением поля зрения в верхне-носовом квадранте

Центральной скотомой

#294

Какие из перечисленных симптомов позволяют подозревать врожденную глаукому у ребенка даже в первые дни после рождения?

Отсутствие реакции зрачка на свет

Увеличение размеров роговицы

Расширение лимба

Глубокая передняя камера

Расширение зрачка

Сужение зрачка

#295

Укажите стадии первичной глаукомы:

Начальная

Незрелая

Развитая

Далекозашедшая

Зрелая

Терминальная

#296

Какие формы первичной глаукомы приняты в современной классификации?

Развитая

Открытоугольная

Закрытоугольная

Смешанная

Далекозашедшая

#297

Клинические формы вторичной глаукомы:

Эссенциальная гипертензия

Посттравматическая глаукома

Глаукомы циклические кризы

Сосудистая и дегенеративная глаукома

Факогенная глаукома

Неопластическая глаукома

Травматическая

#298

Какие из указанных групп препаратов относятся к миотикам?

Холиномиметики

Антихолинэстеразные

Холинолитики

Ингибиторы карбон ангидразы

Бетаадреноблокаторы

Простогландины

#299

Какие из перечисленных препаратов относятся к холиномиметикам?

Ксалатан

Пилокарпин

Карбохолин

Адреналин

Тимолол

#300

Какие из перечисленных препаратов относятся к группе антихолинэстеразных?

Фосфакол

Армин

Ксалатан

Тосмилен

Пилокарпин

Карбохолин

#301

Какие группы препаратов применяются для снижения офтальмотонуса при первичной глаукоме в виде глазных капель?

Мидриатики

Миотики

Кортикостероиды

Простогландины

Бета- адреноблокаторы

Ингибиторы карбонангидразы

#302

Для развитой стадии первичной глаукомы характерно:

Сужение границ в верхнее-носовом квадранте поля зрения на 10 градусов

Сужение границ в верхнее-носовом секторе более чем на 10 градусов

Сохранность центральной части поля зрения меньше 15 градусов

Сужение височной половины поля зрения

Сохранность центральной части поля зрения в пределах 15 градусов

#303

Из перечисленных симптомов отберите признаки, характерные для острого приступа глаукомы, отличающие его от переднего увеита:

Передняя камера глубокая

Зрачок расширен

Боли ограничены глазом

Боли иррадируют в различные области

Роговица отечная, передняя камера мелкая

Жалобы на тошноту

Зрачок сужен

Отмечается смешанная инъекция

#304

Укажите препараты для лечения острого приступа глаукомы:

Миотики холиномиметической группы по схеме

Антихолинэстеразные миотики

Диакарб внутрь, азопт, туссопт в инстиляциях

Бета- адреноблокаторы

Кортикостероиды в инстиляциях

Мидриатики

Аналгетики перос или в/м

Аминазин в/м

#305

Патогенез врожденной глаукомы:

Врожденные аномалии роговицы, сосудистой оболочки, сетчатки

Нарушения углеводного, кальциевого обмена в период внутриутробного развития

Сохранность в углу передней камеры эмбриональной мезодермальной ткани

Гипоплазия, аплазия трабекул, Шлеммова канала, вортикозных вен

Внутриутробная инфекция

#306

Факторы риска на первичную глаукому:

Наследственность

Неудовлетворенность пресбиопическими очками с преждевременной сменой их

Курение, алкоголизм, профессиональные вредности (лучистая энергия, токсическое воздействие химических веществ)

Возраст старше 70 лет

Миопия выше 3.0 D

Эссенциальная гипертензия

#307

Выберите из перечисленного признаки острого приступа глаукомы:

Преципитаты

Передняя камера мелкая

Зрачок расширен

Зрачок сужен

Острая боль ограничена глазным яблоком

Острая боль в глазу с иррадиацией в различные области

#308

Раннюю диагностику открытоугольной глаукомы позволит сделать:

Компьютерная периметрия

Оптическая когерентная томография сетчатки

Исследование проходящим светом

Тонография

Диафаноскопия

Двух-трех часовая тонометрия

#309

Какие симптомы характерны для острой непроходимости центральной артерии сетчатки?

Возникает внезапно

Возникает постепенно с нарастанием симптомов

Резкая потеря зрения вплоть до слепоты

Зрение снижено, но умеренно

Артерии на глазном дне сужены, вплоть до нитевидных

Сетчатка между зрительным нервом и желтым пятном белого цвета

На глазном дне симптом "вишневой косточки"

#310

Какие патогенетические факторы лежат в основе острой непроходимости центральной артерии сетчатки?

Проникновение пигментного эпителия в слои сетчатки с образованием «костных телец»

Спазм центральной артерии сетчатки

Дефекты мембраны Бруха

Тромбоз центральной артерии сетчатки

Эмболия центральной артерии сетчатки

#311

Из перечисленных медикаментов выберите, дающие более быстрый сосудорасширяющий эффект:

Папаверин -внутримышечно

Атропин 0,1 %-ретробульбарно

Нитроглицерин- под язык (если 1 ответ,то этот)

Гепарин - внутримышечно или ретробульбарно

Эуфиллин - внутривенно

Трентал - ретробульбарно

Никотиновая кислота - внутримышечно

Мезатон - в глазных каплях

#312

Какие из перечисленных симптомов характерны для непроходимости центральной вены сетчатки?

Начало внезапное, как и при непроходимости центральной артерии сетчатки

Тромбоз центральной вены сетчатки развивается значительно медленнее, чем артериальная непроходимость

Потеря предметного зрения

Зрение снижается в меньшей степени, чем при артериальной непроходимости

Диск зрительного нерва гиперемирован, отечен, с нечеткими контурами

Вены расширены, извиты, местами теряются в отечной ткани сетчатки, большое количество кровоизлияний

Диск зрительного нерва не изменен

#313

Назначьте лекарственные препараты при непроходимости центральной вены сетчатки или ее ветви:

Антикоагулянты прямого действия с первых дней лечения

Антикоагулянты непрямого действия с первых дней терапии

Кортикостероиды

Фибринолитики, тромболитики

Ангиопротекторы

Сосудорасширяющие препараты

Дезагреганты, антиагреганты

Аналгетики

#314

Офтальмоскопическая картина свежей отслойки сетчатки:

Фон глазного дна равномерно красный

Фон глазного дна соответственно локализации отслойки сероватый

Сосуды резко сужены с прямолинейным ходом

Сетчатка ригидна в виде тяжей и складок

Сетчатка подвижна, колыхается

Сосуды темного цвета, извитые, совершают «червеобразные» движения

Неоваскуляризация, геморрагии

#315

При гипертонической болезни глазное дно характеризуется:

Штопорообразной извитостью премакулярных сосудов

Микроаневризмами, твердыми экссудатами

Патологическим артерио-венозным перекрестом

Симптомом медной и серебряной проволоки

Прогибанием (экскавацией) диска зрительного нерва

Отеком диска зрительного нерва

#316

Для ретробульбарного неврита характерно :

Выраженная офтальмоскопическая картина

Основное проявление – снижение остроты зрения и патология поля зрения

Отсутствие изменений со стороны диска зрительного нерва в начальном периоде

Возможность болей самостоятельных или при движении глазного яблока

Жалобы на фотопсии, метаморфопсии

#317

Какие из перечисленных заболеваний чаще всего вызывают воспалительные процессы в сетчатой оболочке?

Туберкулез

Сифилис

Сахарный диабет

Ревматизм

Гипертоническая болезнь

Гнойные очаги различной локализации

#318

Какие признаки на глазном дне характерны для хориоретинита?

На глазном дне имеется очаг (очаги)

Контуры очага четкие

Контуры очага нечеткие

Помутнение, прилежащего к очагу, стекловидного тела

Стекловидное тело вблизи очага прозрачное

Цвет очага желтоватый, сероватый

Цвет очага черный

#319

Ретинобластому следует диагностировать на основании:

Узкого зрачка

Широкого правильной формы зрачка

Широкого деформированного зрачка

Гипотонии глаза

Желтоватого свечения зрачка

Обнаружения при офтальмоскопии желтоватого бугристого очага

#320

На ранних стадиях диабетической ретинопатии на глазном дне появляются:

Дистрофические очажки типа «костных телец»

Микроаневризмы

Точечные геморрагии

Новообразованные сосуды

Восковидные «твердые» экссудаты

«Мягкие» экссудаты, пролифераты

#321

Ретиноваскулиты ревматической этиологии сопровождаются:

Вовлечением в патологический процесс и артерий, и вен с утолщением их стенок и сужением просвета

Патологическим артерио-венозным перекрестом

Наличием вокруг сосудов сероватых муфт и сероватых пролиферативных очажков в сетчатке

Симптомом «вишневой косточки»

Симптомом Гвиста

#322

Как протекает пигментная дистрофия сетчатки?

Медленно, незаметно для больного на ранних сроках

Протекает остро

Протекает подостро, достигает максимального развития через 4-5 месяцев

Прогрессирует с годами, приводя к слепоте

Зрительные функции сохраняются даже в старческом возрасте

#323

Клиническая картина неврита зрительного нерва складывается из:

Жалоб больного на снижение зрения, нарушение цветовосприятия

Сужение поля зрения или центральной скотомы

Болей, слезотечения, светобоязни

Гиперемии диска зрительного нерва, тушеванности или отсутствия границ, геморрагий на диске

Симптома «вишневой косточки»

#324

Из воспалительных заболеваний сетчатки следует указать следующие:

Ангиоматоз, глиоматоз сетчатки

Центральный серозный хориоретинит

Наружный экссудативный ретинит Коатса

Метастатический ретинит

Перифлебит Илза

Ревматический ретиноваскулит

#325

Выберите из перечисленного методы исследования глазного дна?

Офтальмоскопия

Флюоресцентная ангиография

Скиаскопия

Оптическая когерентная томография сетчатки

Диафаноскопия

#326

Какие клинические состояния глазного дна имеют место при гипертонической болезни?

Препролиферативная ретинопатия

Гипертоническая ангиопатия

Гипертонический ангиосклероз

Ангиоматоз, глиоматоз сетчатки

Гипертоническая ретинопатия, нейроретинопатия

#327

Какие стадии различают при диабетической ретинопатии?

Непролиферативная ретинопатия

Развитая ретинопатия

Терминальная ретинопатия

Препролиферативная ретинопатия

Пролиферативная ретинопатия

#328

Выберите из перечисленного признаки неproлиферативной диабетической ретинопатии :

Микроаневризмы, геморрагии

Макулопатия

Мягкие экссудаты

Неоваскуляризация

Гемофтальм

Твердые экссудаты

#329

Офтальмоскопическая картина при пролиферативной стадии диабетической ретинопатии характеризуется :

Неоваскуляризацией с ростом сосудов в сетчатке и в задние слои стекловидного тела, множественными кровоизлияниями

Гемофтальмом

Развитием пролиферативной ткани

Застойным диском зрительного нерва

Гиперпигментацией

#330

На ранних стадиях диабетической ретинопатии из методов лечения рекомендуют:

Консервативное лечение

Тампонаду силиконом

Лазеркоагуляцию

Антиглаукоматозную операцию

Витрэктомию

#331

Консервативное лечение диабетической ретинопатии предусматривает назначение:

Ангиопротекторов и антикоагулянтов

Сосудорасширяющих препаратов

Гипотензивных препаратов

Антиоксидантов

Препаратов, улучшающих гемодинамику сетчатки

Препаратов, улучшающих метаболические процессы в сетчатке

#332

Показания для витрэктомии:

Гемофтальм с ретинальной неоваскуляризацией

Гемофтальм с витреоретинальной неоваскуляризацией и пролиферацией

Диабетический отек макулы

Рубеоз радужки

Тракционная отслойка сетчатки

#333

Методы исследования, позволяющие определить наличие отслойки сетчатки:

Периметрия

Кампиметрия

Офтальмоскопия

Тонография

Оптическая когерентная томография сетчатки

Ультразвуковая диагностика

#334

Первичная отслойка сетчатки - это :

Следствие новообразования хориоидеи или сетчатки

Следствие гемофтальма нетравматической этиологии

Отслойка при осложненной близорукости

Следствие диабетической ретинопатии

Следствие факоматозов

Травматическая отслойка

#335

Патогенез наружного эксудативного ретинита (болезни Коатса):

Набухание межуточного вещества сетчатки

Воспалительный процесс

Капилляросклероз, повышенная проницаемость капилляров, аневризмы

Неоваскуляризация

Глиоз сетчатки

#336

Для дистрофии Штаргардта характерно :

Дистрофические очаги отмечаются по всей сетчатке

Крапчатость и отек макулярной области в начальной стадии

Очаг в макулярной области бурого цвета

Дистрофические очаги в виде «костных телец»

Отмечается гемералопия

В макуле образуется атрофический очаг в поздних стадиях

#337

При желточной дистрофии Беста:

Процесс локализуется в макулярной области в виде кисты желтого цвета

Дистрофические очаги распределены на периферии сетчатки

Очаги не претерпевают изменения

Заболевание проходит три стадии

Разрыв кисты приводит к кровоизлияниям с образованием в последующем атрофического очага

#338

В качестве причин застойного диска зрительного нерва следует указать на:

Неврит зрительного нерва

Первичную глаукому

Воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек

Интракраниальные новообразования и аневризмы

Травмы черепа

Друзы диска зрительного нерва

Гипотонию глазного яблока

#339

Офтальмоскопическая картина застойного диска зрительного нерва характеризуется:

Увеличением, проминенцией и размытостью границ диска зрительного нерва

Множественными геморрагиями

Расширением артерий

Расширением и извитостью вен

Выраженной гиперемией диска зрительного нерва

Розовато-серым цветом диска зрительного нерва

#340

Для клиники ретробульбарного неврита характерно:

Боль за глазным яблоком и при движениях глазного яблока

Отсутствие жалоб на боли

Медленное нарастание клиники

Быстрое снижение зрительных функций

Постепенное снижение зрительных функций

#341

Особенности клиники наследственной Леберовской атрофии зрительного нерва:

Развивается в раннем детском возрасте

Заболевание отмечается в подростковом и молодом возрасте

Болеют в основном лица мужского пола

Зрение снижается медленно, в течение месяцев

Значительное снижение зрения обоих глаз в течение нескольких дней

Сужение полей зрения концентрическое и в значительной степени

Границы полей зрения нормальные при центральных скотомах

#342

Для ишемии зрительного нерва характерно:

Диск зрительного нерва бледный увеличен, проминирует в стекловидное тело

Гиперемия диска зрительного нерва

Артерии и вены расширены

Артерии резко сужены

Поле зрения в норме

Выявляется гемианопсия

Иммунные реакции с антигеном из ткани зрительного нерва отрицательные

Иммунные реакции с данным антигеном положительные

#343

Какие клинические признаки указывают на сочетанные орбитосинуальные ранения?

Подкожная гематома века

Косоглазие, диплопия

Эмфизема века

Эмфизема глазницы с экзофтальмом

Отрыв зрительного нерва

#344

Офтальмоскопическая картина при разрыве передней части (не далее 10-12 мм) зрительного нерва в ранней стадии проявляется:

Атрофией зрительного нерва

Застойным диском зрительного нерва

Острой непроходимостью центральной вены сетчатки

Острой непроходимостью центральной артерии сетчатки

Ишемией диска зрительного нерва

#345

Что из перечисленного может быть при переломах костей орбиты?

Гемофтальм

Экзофтальм, вплоть до вывиха глазного яблока

Энофтальм

Девияция глазного яблока, диплопия

Ущемление, разрыв, отрыв зрительного нерва

#346

При ранении нижнего века имеет место:

Выворот века

Нарушение целостности слезного канальца

Блефарит

Подкожная гематома века

Заворот века

#347

Какова будет тактика амбулаторного офтальмолога при эрозии роговицы?

Направить больного в офтальмологический стационар

Инстилляции растворов антибиотика, альбуцида, витаминных капель, закладывание глазной мази, наложение асептической повязки

Назначение лечения амбулаторно

Назначить антибиотики per.os

Повторный осмотр через 2-3 дня

#348

Симпатическую офтальмию диагностируют на основании:

Проникающего ранения или полостной операции глаза в анамнезе

Корнеального синдрома

Гемофтальма

Клиники фиброзно-пластического иридоциклита (если несколько вариантов, то это тоже берем)

Офтальмоскопической картины нейроретинита

#349

Прямая контузия глазного яблока проявляется следующими состояниями или признаками:

Гематомой век, гифемой, гемофтальмом

Разрывом склеры

Гипопионом, задними синехиями

Иридодиализом

Эктопией хрусталика, катарактой

Наличием тени инородного тела на рентгенограммах орбиты

Сотрясением сетчатки, отслойкой сетчатки

#350

Этиологические факторы, обуславливающие ожоги органа зрения:

Гамма лучи, нейтроны

Кислоты, щелочи

Термические факторы

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение

Вибрация, ультразвук

#351

Первая помощь при ожоге конъюнктивы и роговицы известью включает:

Инстилляцию гипотензивных препаратов

Инстилляцию мидриатиков, кортикостероидов

Инстилляции – анестетиков с удалением ватным тампоном или «сigaretкой» всех кусочков извести, затем обильное промывание конъюнктивальной полости раствором антисептиков, физиологическим раствором или даже водой с последующей инстилляцией антибиотиков, антисептиков, витаминных капель

Введение ПСС или ПС анатоксина при ожоге второй - четвертой степени

Срочную госпитализацию

#352

Объем первой помощи при электроофтальмии включает:

Инстилляции мидриатиков

Введение ПСС или ПС анатоксина

Множественно (4-6 раз) инстилляции анестетиков

Инстилляции дезинфицирующих капель

Инстилляции кортикостероидов

#353

При наличии металлического инородного тела в слоях роговицы следует:

Удалить инородное тело «сigaretкой»

Удалить инородное тело глазным магнитом или «копьем»

Струйно, под напором, промыть поверхность глазного яблока

Инстиллировать дезинфицирующие и витаминные капли, заложить за веки мазь с антибиотиками, наложить асептическую повязку

Назначить это лечение амбулаторно с повторным осмотром

Назначить кортикостероиды

#354

К осложнениям проникающего ранения глазного яблока относятся:

Внутриглазная инфекция эндофтальмит, панофтальмит

Острый приступ глаукомы

Бельмо роговицы

Металлоз

Катаракта

Симпатическая офтальмия

#355

Достоверными признаками проникающего ранения глазного яблока являются:

Мелкая передняя камера

Сквозная рана роговицы

Гипертензия глазная

Отверстие в радужной оболочке

Ущемление, выпадение внутренних оболочек, стекловидного тела

Корнеальный синдром

Наличие тени инородного тела на обзорной рентгенограмме орбиты

#356

Какие клинические признаки определяют III степень ожога глаза:

Ишемия конъюнктивы

Гиперемия конъюнктивы

Некроз конъюнктивы

Поверхностная эрозия роговицы

Некроз роговицы, роговица имеет вид матового стекла

Роговица приобретает фарфоровый вид

#357

Укажите клинические формы контузии глазного яблока:

Гифема, гемофтальм

Ириододиализ

Косоглазие, офтальмоплегия

Эктопия хрусталика, катаракта

Симпатическая офтальмия

Симблефарон

«Сотрясение» сетчатки, отслойка сетчатки

#358

Клинические признаки халькоза:

Катаракта, имеющая форму подсолнуха

Отложение под передней капсулой хрусталика оранжево-желтых точек, пятен

Офтальмоскопическая картина напоминает пигментную дегенерацию сетчатки

Зеленого цвета отложения в эндотелии роговицы и в стекловидном теле

Оранжевого цвета взвесь в стекловидном теле

Красноватого цвета с металлическим блеском глыбки в макуле